

Protocolo Emergencial de Saúde

*Enquanto o plano nega e a fila do SUS não anda, alguém precisa correr contra o tempo.
Esse alguém é você.*

Cliente — Vilmar Guimarães Júnior · Advocacia em Direito à Saúde
Escopo — Posicionamento de Instagram + Estratégia de Tráfego
Frentes — Plano privado e SUS · Públicos — Criança e melhor idade
Investimento inicial — R\$ 500,00
Julho de 2026

PROTOCOLO EMERGENCIAL
Nº 001 · SAÚDE SUPLEMENTAR
PLANO PRIVADO + SUS

PROCESSO Nº 01 — DIAGNÓSTICO

O problema não é a negativa. É o tempo.

Todo paciente que tem um procedimento, exame ou medicamento de alto custo negado passa pela mesma sequência: liga pra operadora, abre reclamação na ANS, espera. Quem depende do SUS enfrenta a mesma espera numa fila que não anda. Nos dois casos, o tratamento não acontece enquanto a resposta não vem.

PROBLEMA CENTRAL

A negativa

Muitas negativas de plano e recusas do SUS podem ser ilegais — e existe caminho jurídico pra buscar reversão com agilidade, quando presentes os requisitos legais.

PROBLEMA SOFISTICADO

O tempo perdido

Mesmo quem procura ajuda cai em canais lentos (ANS, ouvidoria do SUS) ou advogado generalista que não domina o pedido de urgência. O quadro de saúde piora enquanto o processo tramita.

Por que isso muda o posicionamento: o mercado de advocacia em saúde compete em conhecimento jurídico. O escritório compete em **velocidade e método** — e em mirar as duas frentes onde a negativa acontece, não só uma.

“Direito à saúde não tem fila de espera administrativa. Tem prazo legal, e ele é curto.”

PROCESSO Nº 02 — POSICIONAMENTO

O discurso que atrai quem já está frustrado

Nº	ELEMENTO	DEFINIÇÃO
01	Público	Pessoas com procedimento, cirurgia, exame ou medicamento de alto custo negado por plano de saúde — ou represado na fila do SUS. Já tentaram resolver sozinhas e não conseguiram.
02	Quem decide	Quase nunca o próprio paciente. É a família: a mãe da criança, a filha do idoso, o cônjuge. É com quem cuida que a comunicação fala.
03	Efeito colateral em comum	Tempo perdido, saúde agravando, dinheiro saindo do bolso, sensação de estar sozinho contra o sistema — privado ou público.

NOME DO MÉTODO

Protocolo Emergencial de Saúde

Comunica exatamente o que o cliente precisa sentir: urgência e procedimento. Não é “mais um advogado”, é um protocolo a ser seguido quando o tempo é curto — e vale tanto pra quem tem plano quanto pra quem depende do SUS.

PROMESSA

“Oriento quem teve procedimento ou medicamento negado — pelo plano de saúde ou pelo SUS — a buscar, com agilidade e dentro da lei, a resposta jurídica adequada ao seu caso.”

Promessa de processo e competência — nunca de resultado. Sem projeção de desfecho, sem valores, sem “consulta grátis” como isca, conforme o Código de Ética da OAB e o Provimento 205/2021.

PROCESSO Nº 03 — NOVA IDENTIDADE

O que muda no perfil

BIO

“Advocacia em Direito à Saúde · Negativas de cirurgia, exame e medicamento de alto custo · Plano privado e SUS · Casos urgentes com prioridade de análise · OAB/BA nº _____”

O número da OAB entra na bio e nos criativos — sinal de seriedade e requisito de identificação da publicidade profissional.

FOTO DE PERFIL

Autoridade e descrição

Retrato único, sério, fundo neutro. É a única aparição pessoal — o resto da comunicação roda sem rosto, o que combina com o estilo reservado do escritório.

DESTAQUES

“Comece aqui” + “Seus direitos”

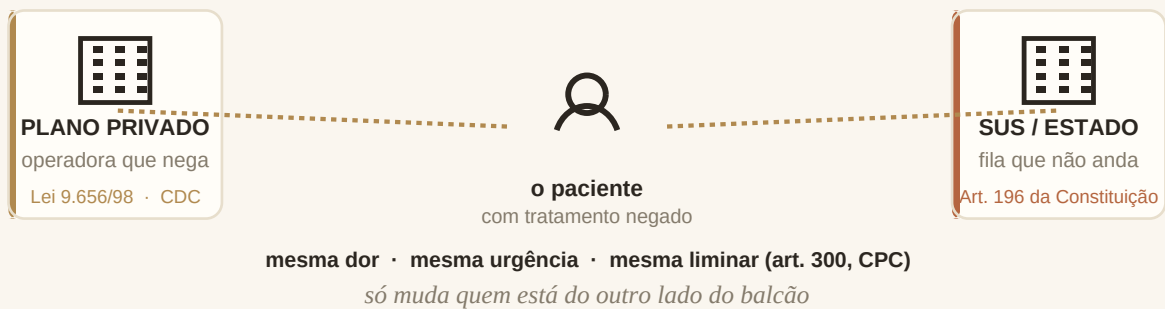
O primeiro explica o método em 3 passos. O segundo reúne conteúdo educativo sobre a lei — autoridade sem depender de depoimento de cliente.

Regra de consistência: tudo no perfil fala de uma coisa só — o Protocolo Emergencial de Saúde. Bio, destaques e os 3 primeiros posts fixados repetem a mesma mensagem de formas diferentes.

PROCESSO Nº 04 — ONDE A BRIGA ACONTECE

Plano privado e SUS — duas frentes, não uma

Cerca de **7 em cada 10 brasileiros não têm plano de saúde** e dependem do SUS — que nega ou represa igual (medicamento de alto custo, cirurgia, vaga de UTI, terapia “fora da tabela”). Mirar só a operadora deixa metade do mercado de fora.



Contra o Estado, a base é o **art. 196 da Constituição** (saúde é direito de todos e dever do Estado). Contra o plano, a Lei 9.656/98 e o CDC. A ferramenta que destrava os dois é a mesma: a **tutela de urgência do art. 300 do CPC**.

≈ 7 em 10

brasileiros dependem do SUS,
não de plano

Art. 196

a Constituição obriga o Estado a
dar saúde

Art. 300

a mesma liminar vale nas duas
frentes

PROCESSO Nº 05 — OS DOIS PÚBLICOS QUE MAIS CONVERTEM

A criança e a melhor idade

Dentro da lógica de que quem decide é a família, dois públicos são os mais recorrentes e emocionais — vale concentrar conteúdo e criativo neles.

PÚBLICO 01 · A CRIANÇA



A criança que precisa de terapia

Autismo (TEA) é hoje uma das maiores demandas de saúde do país. Plano e SUS negam ou cortam a carga horária de terapia que o médico pediu, e cada mês perdido é desenvolvimento que não volta. A mãe vira a melhor propaganda no grupo de outras mães.

O que costuma ser negado: terapia ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, acompanhante terapêutico na escola, horas de terapia negadas.

Recorrente, emocional, com boca a boca fortíssimo entre mães.

PÚBLICO 02 · A MELHOR IDADE



O idoso que o sistema deixa esperando

A família não aceita ver o pai ou a mãe na fila enquanto a saúde piora. A urgência é literal, e o Estatuto do Idoso ainda dá prioridade na tramitação — a liminar sai mais rápido.

O que costuma ser negado: home care e internação domiciliar, medicamento oncológico e de alto custo, cirurgia negada “por idade”, fisioterapia, insumos.

Decisão movida por amor de filho, com prioridade legal de quem já tem idade.

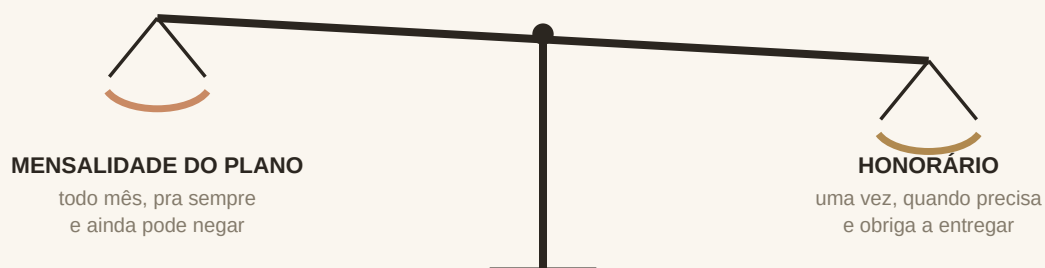
PROCESSO Nº 06 — O PULO DO GATO É NO DINHEIRO

O advogado como plano de saúde

A maior objeção nunca é o valor do honorário. É o medo: “e se eu pagar e não der certo?”. Com o público do SUS, esse medo cai sozinho — quem depende do SUS **já não paga plano nenhum**. O dinheiro que iria pra uma mensalidade que nega está livre. O honorário se reposiciona como o melhor investimento em saúde que essa família pode fazer.



Da esquerda pra direita: o plano que nega (ou a fila do SUS) sai de cena; entra o advogado; e o que o cliente leva pra casa é o tratamento liberado. É essa a promessa — de processo e de presença, nunca de resultado garantido.



o cliente não compra uma petição — compra a certeza do tratamento

Sobre a ética: isso é reposicionamento de valor percebido, não promessa de ganho. Nada de “recupero seu dinheiro” ou “ganho garantido”. Vende-se presença, rapidez e método — o desfecho é sempre da Justiça.

PROCESSO N° 07 — CONTEÚDO

Fase 1: 9 posts pra construir posicionamento

Três posts fixados carregam o peso da mensagem. Os demais sustentam e repetem sob ângulos diferentes, cobrindo as duas frentes e os dois públicos.

N°	POST	FRENTE / PÚBLICO
F1	O que é o Protocolo Emergencial de Saúde — fixado	Todos
F2	A vida depois da liminar, sem prometer desfecho — fixado	Todos
F3	“Enquanto você espera a ANS/fila resolver...” — fixado	Todos
04	Caso ilustrativo anonimizado: as etapas do método	Prova / credibilidade
05	“3 sinais de que a negativa pode ser ilegal”	Educação rápida
06	Terapia de criança com TEA negada: o que fazer	Nicho criança
07	Idoso na fila do SUS: home care e alto custo	Nicho melhor idade
08	SUS também se resolve na Justiça (art. 196)	Frente SUS
09	“O que a lei diz” — CPC 300, 9.656/98, 14.454/22	Autoridade recorrente

Sobre prova social: nada de depoimento de cliente ou print de decisão como propaganda — a publicidade da OAB veda. Autoridade se constrói citando a lei, não expondo caso. Casos são sempre “ilustrativos e anonimizados”.

PROCESSO Nº 07 — PEÇA-CHAVE

Post fixado 3/3 — Roteiro completo

- | | |
|---------------------|--|
| CARD 1 | Enquanto você espera a ANS ou a fila do SUS resolver seu problema, você fica cada vez mais sem tempo pro seu tratamento. O sistema não tem prazo pra te salvar. Tem prazo pra protocolar. |
| CARD 2 | Reclamação na ANS ou na ouvidoria não é ação judicial. Não obriga ninguém a liberar nada. Você abre um processo administrativo que pode levar semanas. Enquanto isso, sua cirurgia, exame ou remédio continua negado. |
| CARD 3 | Existe uma ferramenta prevista em lei — a tutela de urgência (art. 300 do CPC), a chamada liminar. Quando o caso preenche os requisitos legais, o juiz pode determinar que o plano ou o Estado cumpra em prazo curto. E ela precisa ser pedida do jeito certo, no momento certo. |
| CARD 4 | O Protocolo Emergencial de Saúde nasceu pra isso. Análise do seu caso, verificação de possível ilegalidade na negativa e, quando cabível, pedido de urgência direto na Justiça — no plano ou contra o Estado. |
| CARD 5 | Não é reclamação. Não é mediação. É pedido de decisão judicial. Cada caso é único e depende de análise — mas quem age no tempo certo, com a documentação certa, disputa em outras condições. |
| CARD 6 | O que está em jogo não é dinheiro. É tempo de tratamento que não volta. Cada semana de espera é uma semana a menos de recuperação, de qualidade de vida, de tranquilidade. |
| CARD 7 | Direito à saúde não tem fila de espera administrativa. Tem prazo legal, e ele é curto. |
| CARD 8 · CTA | Se seu plano negou ou o SUS represou cirurgia, exame ou medicamento de alto custo, guarde a negativa por escrito e não espere sem prazo. Envie a palavra PROTOCOLO no Direct. |

DIGA ASSIM

“Quando o caso preenche os requisitos, dá pra pedir uma liminar com urgência.”

“Analiso seu caso e, se cabível, entro com o pedido de urgência.”

EVITE

“Garanto a liminar / ganho garantido.”

“Meus clientes já têm data marcada pro procedimento.”

PROCESSO Nº 08 — TRÁFEGO

Orçamento enxuto, fechamento rápido

R\$ 500 de investimento inicial · 100% em campanha de mensagem · foco em primeiros fechamentos. Orçamento baixo não sustenta testar várias campanhas ao mesmo tempo — toda a verba vai pra gerar conversa qualificada no WhatsApp o mais rápido possível.



Formulário e LGPD: o formulário pergunta sobre saúde — dado sensível (art. 11 da LGPD). Precisa de aviso curto de consentimento, e as respostas ficam em ambiente restrito, não em planilha aberta.

Resposta em até 1h útil: se o posicionamento é velocidade, o atendimento é a prova. Mensagem automática confirma recebimento; resposta pessoal em até 1h útil pede negativa por escrito e laudo, e já oferece dois horários de reunião.

PROCESSO Nº 09 — MÉTRICAS & CONFORMIDADE

Como saber se está funcionando

MÉTRICA	META FASE 1	SE ESTIVER FORA
Custo por conversa iniciada	Até R\$ 40	Trocar criativo primeiro, público depois — nunca os dois ao mesmo tempo
Taxa de qualificação	Acima de 50%	Ajustar as perguntas do formulário ou o texto do anúncio
Comparecimento em reunião	Acima de 60%	Encurtar o tempo entre contato e reunião
Fechamentos no mês	1 a 2	Se as métricas acima batem e não fecha, o problema é a condução da reunião — não o tráfego

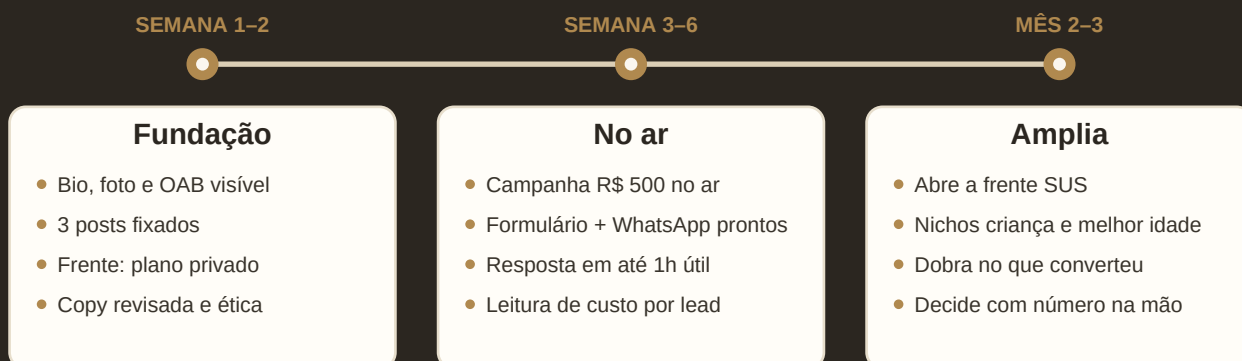
PODE — TODA PEÇA PRECISA TER

- ✓ Caráter informativo ou educativo predominante
- ✓ Identificação: nome do advogado + número da OAB
- ✓ Base legal citada quando fizer afirmação jurídica

NÃO PODE — REPROVA NA HORA

- ✗ Promessa de resultado (“reverso”, “garanto”, “em X dias”)
- ✗ Valores de honorário ou de causa
- ✗ Depoimento de cliente ou print de decisão como propaganda
- ✗ “Consulta grátis” como isca de captação

O que acontece a partir daqui



O objetivo da Fase 1 não é escalar. É **provar**, com o menor investimento possível, que o protocolo funciona nas duas frentes e nos dois públicos — e então saber, com número na mão, onde vale a pena colocar mais verba.

Nenhuma peça vai ao ar sem validação prévia: na OAB, quem responde pela publicidade é o advogado.

